QCM · Santé mondiale et santé en France

UE C1.1 · Semestre 1 · 56 questions · niveaux facile / intermédiaire / difficile. Chaque question comporte **cinq propositions**, et le **nombre exact de réponses attendues est annoncé**. Les corrigés argumentés se trouvent intégralement après la dernière question.

CHAPITRE · Santé mondiale, OMS et One Health

Question 01 · facile · 2 bonnes réponses

La notion de santé utilisée en santé mondiale : quelles affirmations sont exactes ?

- ☐ **A.** Exclut les facteurs environnementaux
- ☐ **B.** Inclut des dimensions physiques, mentales et sociales
- ☐ **C.** Ne concerne que les maladies diagnostiquées
- ☐ **D.** Dépend aussi du contexte de vie
- ☐ **E.** Se réduit à une consultation individuelle

Question 02 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

À propos de l'OMS, quelles propositions sont justes ?

- ☐ **A.** Elle remplace les ministères nationaux de la Santé
- ☐ **B.** C'est une institution spécialisée des Nations unies
- ☐ **C.** Elle contribue à des normes et recommandations internationales
- ☐ **D.** Elle coordonne des réponses sanitaires internationales
- ☐ **E.** Elle fournit tous les soins hospitaliers du monde

Question 03 · difficile · 3 bonnes réponses

Le concept One Health met explicitement en relation :

- ☐ **A.** La santé humaine
- ☐ **B.** Uniquement le système hospitalier
- ☐ **C.** La santé des écosystèmes
- ☐ **D.** Uniquement la vaccination
- ☐ **E.** La santé animale

Question 04 · facile · 1 bonne réponse

Quel exemple illustre directement l'intérêt d'une approche One Health ?

- ☐ **A.** Supprimer toutes les surveillances animales
- ☐ **B.** Traiter une fracture isolée sans facteur environnemental
- ☐ **C.** Étudier une zoonose avec son réservoir animal et son environnement
- ☐ **D.** Mesurer seulement la tension d'une personne
- ☐ **E.** N'étudier que les dépenses de santé

CHAPITRE · OMD, ODD et pauvreté

Question 05 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Quelles associations entre programmes et dates sont correctes ?

- ☐ **A.** ODD 3 : bonne santé et bien-être
- ☐ **B.** OMD : 2000–2015
- ☐ **C.** OMD : dix-sept objectifs
- ☐ **D.** ODD : 2015–2030
- ☐ **E.** ODD : 1990–2000

Question 06 · difficile · 2 bonnes réponses

Pour suivre l'extrême pauvreté mondiale, il faut préciser :

- ☐ **A.** L'année et le champ géographique
- ☐ **B.** Le nombre total de personnes pauvres se compare sans préciser s'il s'agit d'un effectif ou d'un pourcentage
- ☐ **C.** Seulement le nom du pays le plus pauvre
- ☐ **D.** Uniquement la couleur du graphique
- ☐ **E.** Le seuil monétaire retenu

Question 07 · facile · 2 bonnes réponses

À propos d'une cible ODD 2030, quelles affirmations sont exactes ?

- ☐ **A.** Elle doit être confondue avec une projection
- ☐ **B.** Elle garantit que la cible est déjà atteinte
- ☐ **C.** Une cible internationale prouve à elle seule que sa politique est responsable de toute évolution
- ☐ **D.** Elle est un objectif à atteindre
- ☐ **E.** Elle peut être suivie par des indicateurs

Question 08 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Une proportion de personnes en pauvreté extrême diminue. Que peut-on conclure ?

- ☐ **A.** Le nombre absolu a forcément diminué dans la même proportion
- ☐ **B.** Toute pauvreté a disparu
- ☐ **C.** La part relative a diminué selon le même seuil
- ☐ **D.** Il faut connaître la population totale pour déduire l'effectif
- ☐ **E.** Le seuil utilisé doit être précisé

CHAPITRE · Indicateurs de santé

Question 09 · difficile · 3 bonnes réponses

Un indicateur de santé peut servir à :

- ☐ **A.** Comparer des évolutions dans le temps
- ☐ **B.** Décrire un état de santé collectif
- ☐ **C.** Évaluer une politique publique
- ☐ **D.** Prouver seul la cause d'une évolution
- ☐ **E.** Remplacer toutes les enquêtes de terrain

Question 10 · facile · 3 bonnes réponses

Avant de comparer deux taux de mortalité, il faut vérifier :

- ☐ **A.** Seulement le nombre de pages du rapport
- ☐ **B.** La période de mesure
- ☐ **C.** Le dénominateur
- ☐ **D.** La structure par âge ou la standardisation
- ☐ **E.** Uniquement la couleur de la courbe

Question 11 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Quel énoncé décrit un indicateur épidémiologique ?

- ☐ **A.** La densité d'incidence d'une infection
- ☐ **B.** Le cours d'une monnaie uniquement
- ☐ **C.** Un taux de décès attribués à une affection
- ☐ **D.** Le nombre de chaises d'une salle
- ☐ **E.** La prévalence d'une maladie

Question 12 · difficile · 3 bonnes réponses

Une estimation mondiale issue d'un modèle statistique doit être présentée :

- ☐ **A.** Avec l'année de référence
- ☐ **B.** Comme un résultat observé dans tous les pays
- ☐ **C.** Comme une mesure nécessairement exacte
- ☐ **D.** Avec ses limites et son champ
- ☐ **E.** Avec la source de données utilisée

CHAPITRE · Démographie et naissances

Question 13 · facile · 3 bonnes réponses

Une population mondiale augmente et son taux de croissance diminue. Quelles affirmations sont possibles ?

- ☐ **A.** Toute projection devient certaine
- ☐ **B.** La variation absolue et le taux sont distincts
- ☐ **C.** Les deux phénomènes peuvent coexister
- ☐ **D.** Le ralentissement du taux signifie une baisse immédiate du nombre d'habitants
- ☐ **E.** L'effectif augmente encore

Question 14 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Concernant la variation d'une population nationale, quels facteurs entrent en jeu ?

- ☐ **A.** Décès
- ☐ **B.** Uniquement l'espérance de vie
- ☐ **C.** La superficie du pays comme seul facteur
- ☐ **D.** Naissances
- ☐ **E.** Migrations

Question 15 · difficile · 1 bonne réponse

Le chiffre de 639 533 naissances en 2023 désigne :

- ☐ **A.** Une estimation de 2026
- ☐ **B.** La France entière avec tous les territoires
- ☐ **C.** La France métropolitaine
- ☐ **D.** Le total des nouveau-nés européens
- ☐ **E.** Un chiffre de décès

Question 16 · facile · 2 bonnes réponses

Une pyramide des âges à base étroite et aux tranches adultes élargies évoque :

- ☐ **A.** Une baisse relative des jeunes classes d'âge
- ☐ **B.** Un vieillissement démographique
- ☐ **C.** Une forte natalité obligatoirement
- ☐ **D.** La forme d'une pyramide identifie à elle seule la cause exacte du vieillissement
- ☐ **E.** Un décès immédiat de tous les nouveau-nés

CHAPITRE · Natalité, mortalité et espérance de vie

Question 17 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Le taux brut de natalité annuel est calculé à partir :

- ☐ **A.** D'un multiplicateur usuel de 1 000
- ☐ **B.** Des naissances vivantes annuelles
- ☐ **C.** De la taille des maternités
- ☐ **D.** Des seuls décès hospitaliers
- ☐ **E.** De la population de référence de l'année

Question 18 · difficile · 2 bonnes réponses

Pourquoi un taux brut de mortalité français peut-il dépasser le taux mondial ?

- ☐ **A.** Cela prouve que chaque Français reçoit de moins bons soins
- ☐ **B.** Le taux brut mesure forcément la létalité d'une maladie
- ☐ **C.** Un taux brut suffit à juger de la qualité de deux systèmes de soins malgré des âges très différents
- ☐ **D.** La population française est en moyenne plus âgée
- ☐ **E.** Un taux brut est sensible à la structure par âge

Question 19 · facile · 3 bonnes réponses

L'espérance de vie à la naissance est :

- ☐ **A.** Calculée pour une génération fictive
- ☐ **B.** Une prédiction détaillée des progrès médicaux futurs
- ☐ **C.** Une date de décès certaine pour chaque nouveau-né
- ☐ **D.** Exprimée en années
- ☐ **E.** Un indicateur fondé sur les mortalités par âge de la période

Question 20 · intermédiaire · 2 bonnes réponses

Concernant la France en 2023, les valeurs approximatives de l'espérance de vie à la naissance sont :

- ☐ **A.** Supérieures chez les hommes dans les données citées
- ☐ **B.** 50 ans chez les deux sexes
- ☐ **C.** 80,0 ans chez les hommes
- ☐ **D.** 85,7 ans chez les femmes
- ☐ **E.** Toujours égales entre sexes

CHAPITRE · Mortalité maternelle

Question 21 · difficile · 3 bonnes réponses

Selon la définition internationale, le décès maternel peut survenir :

- ☐ **A.** À n'importe quel âge du bébé, sans limite temporelle
- ☐ **B.** Pendant la grossesse
- ☐ **C.** Seulement pendant les 28 premiers jours de vie du bébé
- ☐ **D.** D'une cause liée à la grossesse ou à sa prise en charge
- ☐ **E.** Dans les 42 jours après la fin d'une grossesse

Question 22 · facile · 2 bonnes réponses

Le rapport de mortalité maternelle (RMM) est exprimé :

- ☐ **A.** Avec la population masculine au dénominateur
- ☐ **B.** En pourcentage sans unité complémentaire
- ☐ **C.** Pour 10 naissances vivantes
- ☐ **D.** En décès maternels au numérateur
- ☐ **E.** Pour 100 000 naissances vivantes

Question 23 · intermédiaire · 1 bonne réponse

L'ODD 3.1 fixe comme objectif mondial pour 2030 :

- ☐ **A.** RMM inférieur à 70 pour 100 naissances
- ☐ **B.** Suppression de toutes les grossesses à risque
- ☐ **C.** Objectif sans date
- ☐ **D.** Cible déjà atteinte en 2023
- ☐ **E.** RMM inférieur à 70 pour 100 000 naissances vivantes

Question 24 · difficile · 2 bonnes réponses

Le constat mondial 2023 publié par l'OMS correspond à :

- ☐ **A.** Un décès maternel environ toutes les deux minutes
- ☐ **B.** Deux décès maternels chaque minute
- ☐ **C.** Une absence de disparité régionale
- ☐ **D.** Environ 260 000 décès maternels
- ☐ **E.** Les estimations mondiales proviennent d'un recensement nominatif exhaustif des décès dans tous les pays

CHAPITRE · Mortalité infantile et néonatale

Question 25 · facile · 2 bonnes réponses

La mortalité néonatale concerne les décès :

- ☐ **A.** Avant la fin du premier mois approximativement
- ☐ **B.** Pendant les 28 premiers jours de vie
- ☐ **C.** Liés uniquement au VIH
- ☐ **D.** Exclusivement au-delà de 42 jours
- ☐ **E.** Avant 5 ans sans précision

Question 26 · intermédiaire · 2 bonnes réponses

Quelle définition est exacte ?

- ☐ **A.** Under-five mortality : décès avant 5 ans
- ☐ **B.** Infant mortality : décès avant 1 an
- ☐ **C.** Infant mortality : décès avant 10 ans
- ☐ **D.** Toutes ces mesures ont le même dénominateur et même horizon
- ☐ **E.** Néonatal : décès dans les 42 jours après grossesse de la mère

Question 27 · difficile · 2 bonnes réponses

Parmi les cibles ODD 3.2 pour 2030, lesquelles sont correctes ?

- ☐ **A.** Mortalité des moins de 5 ans ≤ 25 pour 1 000
- ☐ **B.** Moins de 5 ans ≤ 12 pour 100 000
- ☐ **C.** Mortalité néonatale ≤ 12 pour 1 000 naissances vivantes
- ☐ **D.** Absence de cible pour les enfants
- ☐ **E.** Néonatale ≤ 70 pour 100 000

Question 28 · facile · 3 bonnes réponses

Que montrent les courbes historiques de mortalité des moins de cinq ans ?

- ☐ **A.** Un ralentissement de la baisse sur une période récente
- ☐ **B.** L'inversion générale de toutes les courbes
- ☐ **C.** Des différences persistantes entre régions
- ☐ **D.** Une baisse globale depuis 2000
- ☐ **E.** L'égalité des indicateurs entre régions dès 2015

CHAPITRE · Incidence, prévalence et personnes-temps

Question 29 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Huit personnes malades parmi 100 observées à un instant :

- ☐ **A.** La prévalence inclut des cas anciens et récents
- ☐ **B.** Prévalence ponctuelle de 8 %
- ☐ **C.** Incidence cumulée de 8 % nécessairement
- ☐ **D.** Il faut connaître les nouveaux cas pour calculer l'incidence
- ☐ **E.** Le taux d'incidence est 8 personnes-années

Question 30 · difficile · 3 bonnes réponses

Neuf nouveaux cas parmi 100 personnes initialement indemnes suivies intégralement pendant deux ans :

- ☐ **A.** Un taux de 9 cas/personne-année
- ☐ **B.** Le risque cumulé porte sur la période entière
- ☐ **C.** Incidence cumulée de 9 % sur 2 ans
- ☐ **D.** Prévalence ponctuelle automatiquement 9 %
- ☐ **E.** Des cas apparus pendant le suivi

Question 31 · facile · 2 bonnes réponses

Le dénominateur d'un taux d'incidence comprend :

- ☐ **A.** Les naissances du territoire quelle que soit la maladie
- ☐ **B.** Le temps perdu de vue doit être compté comme du temps réellement observé à risque
- ☐ **C.** Des personnes-années ou personnes-mois
- ☐ **D.** La somme des personnes-temps à risque
- ☐ **E.** Uniquement les personnes malades au dernier jour

Question 32 · intermédiaire · 2 bonnes réponses

Quelle affirmation est scientifiquement exacte ?

- ☐ **A.** La prévalence décrit exclusivement les nouveaux cas
- ☐ **B.** Le taux d'incidence et la contagiosité sont synonymes
- ☐ **C.** Le taux d'incidence renseigne la vitesse d'apparition des nouveaux cas
- ☐ **D.** Une personne perdue de vue n'apporte pas nécessairement le même temps de suivi que les autres
- ☐ **E.** La prévalence n'a pas de dénominateur

CHAPITRE · Transition épidémiologique

Question 33 · difficile · 1 bonne réponse

Quelle catégorie domine la mortalité globale selon les tendances présentées ?

- ☐ **A.** Exclusivement tuberculose
- ☐ **B.** Uniquement accidents
- ☐ **C.** Maladies non transmissibles
- ☐ **D.** Aucune grande catégorie
- ☐ **E.** Uniquement maladies vectorielles

Question 34 · facile · 3 bonnes réponses

Quelles sont les maladies non transmissibles ?

- ☐ **A.** Paludisme
- ☐ **B.** Diabète
- ☐ **C.** Tuberculose active
- ☐ **D.** Maladies cardiovasculaires
- ☐ **E.** Cancers

Question 35 · intermédiaire · 1 bonne réponse

La transition épidémiologique peut comporter :

- ☐ **A.** L'élimination instantanée de tout risque infectieux
- ☐ **B.** Une égalité parfaite entre pays
- ☐ **C.** Une réduction relative du poids des infections
- ☐ **D.** Une baisse obligatoire de l'espérance de vie pendant toute la transition
- ☐ **E.** La disparition des maladies chroniques dans les pays à revenu élevé

Question 36 · difficile · 3 bonnes réponses

Comment interpréter un gradient Nord-Sud des indicateurs de santé ?

- ☐ **A.** Comme un raccourci de disparités historiques
- ☐ **B.** En tenant compte des déterminants sociaux et de l'accès aux soins
- ☐ **C.** Comme une description parfaite de chaque pays
- ☐ **D.** Avec des inégalités possibles dans chaque pays
- ☐ **E.** Comme une différence exclusivement génétique

CHAPITRE · VIH et sida

Question 37 · facile · 2 bonnes réponses

Quelle distinction VIH / sida est exacte ?

- ☐ **A.** Le sida correspond à un virus complètement différent
- ☐ **B.** Une infection par le VIH ne se traite jamais
- ☐ **C.** Le VIH affecte les défenses immunitaires
- ☐ **D.** Le sida est le stade avancé de l'infection par le VIH
- ☐ **E.** Le VIH est une bactérie

Question 38 · intermédiaire · 2 bonnes réponses

Pour une personne vivant avec le VIH au stade sida, les antirétroviraux :

- ☐ **A.** Guérissent définitivement le VIH
- ☐ **B.** Restent indiqués
- ☐ **C.** Les infections opportunistes au stade sida ne nécessitent aucune prise en charge particulière
- ☐ **D.** Participent au contrôle de l'infection
- ☐ **E.** Doivent toujours être interrompus

Question 39 · difficile · 3 bonnes réponses

À propos de la prévention biomédicale du VIH :

- ☐ **A.** PrEP et TPE sont identiques
- ☐ **B.** TPE/PEP = prise en charge après exposition
- ☐ **C.** La PrEP se discute chez toute personne éligible exposée
- ☐ **D.** PrEP interdite aux femmes
- ☐ **E.** PrEP = prévention avant une exposition

Question 40 · facile · 3 bonnes réponses

La formule « indétectable = intransmissible » signifie :

- ☐ **A.** Protection contre toutes les IST
- ☐ **B.** Prévention efficace de la transmission sexuelle du VIH
- ☐ **C.** Sous contrôle thérapeutique durable, pas de transmission sexuelle du VIH
- ☐ **D.** La charge virale doit être effectivement contrôlée
- ☐ **E.** Arrêt systématique de tout suivi médical

CHAPITRE · Maladies transmissibles

Question 41 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

À propos du paludisme, quels énoncés sont justes ?

- ☐ **A.** Transmission habituelle par une femelle Anopheles
- ☐ **B.** P. falciparum associé aux formes graves
- ☐ **C.** Transmission ordinaire par simple poignée de main
- ☐ **D.** Agent parasite du genre Plasmodium
- ☐ **E.** Maladie uniquement présente en France

Question 42 · difficile · 3 bonnes réponses

Dans le paludisme, les mesures de prévention comportent :

- ☐ **A.** Arrêt de toute prévention dès la première fièvre
- ☐ **B.** Éducation et prévention territoriale
- ☐ **C.** Moustiquaires adaptées
- ☐ **D.** Lutte contre les piqûres et vecteurs
- ☐ **E.** Uniquement vaccination rougeole

Question 43 · facile · 2 bonnes réponses

Concernant la tuberculose latente :

- ☐ **A.** Une infection tuberculeuse latente non active est contagieuse par la toux
- ☐ **B.** Elle n'est pas contagieuse en elle-même
- ☐ **C.** Elle se manifeste toujours par hémoptysie
- ☐ **D.** Elle peut rester asymptomatique
- ☐ **E.** Elle est due à un parasite

Question 44 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

La tuberculose pulmonaire active peut :

- ☐ **A.** Nécessiter plusieurs antibiotiques sur plusieurs mois
- ☐ **B.** Se transmettre par aérosols
- ☐ **C.** Être reconnue uniquement par une hémoptysie obligatoire
- ☐ **D.** Être causée par un moustique anophèle
- ☐ **E.** Justifier des précautions respiratoires adaptées

Question 45 · difficile · 1 bonne réponse

Quel exemple représente un risque infectieux émergent ?

- ☐ **A.** Arthrose
- ☐ **B.** Dyslipidémie
- ☐ **C.** L'hypertension artérielle
- ☐ **D.** Ebola
- ☐ **E.** La cataracte

CHAPITRE · Maladies cardiovasculaires et prévention

Question 46 · facile · 3 bonnes réponses

Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, on peut retenir :

- ☐ **A.** Le groupe sanguin comme seule cause
- ☐ **B.** Tabagisme
- ☐ **C.** L'absence de toute interaction avec le diabète
- ☐ **D.** Dyslipidémie
- ☐ **E.** Hypertension artérielle

Question 47 · intermédiaire · 1 bonne réponse

Quels énoncés décrivent des événements ou maladies cardiovasculaires ?

- ☐ **A.** AVC
- ☐ **B.** Une infection à VIH
- ☐ **C.** Paludisme
- ☐ **D.** Onchocercose
- ☐ **E.** Une crise d'asthme

Question 48 · difficile · 3 bonnes réponses

Pourquoi nombre absolu de décès et taux de mortalité standardisé peuvent-ils évoluer différemment ?

- ☐ **A.** Parce que ce sont obligatoirement deux graphiques erronés
- ☐ **B.** Vieillissement de la population
- ☐ **C.** Changement de l'effectif total
- ☐ **D.** Parce que standardisé signifie « inventé »
- ☐ **E.** Progrès de prévention et de prise en charge

Question 49 · facile · 3 bonnes réponses

Le rôle infirmier dans la prévention des maladies chroniques comprend :

- ☐ **A.** Remplacement complet du médecin
- ☐ **B.** Orientation devant un signe d'alerte
- ☐ **C.** Éducation et repérage des facteurs de risque
- ☐ **D.** Diagnostic médical autonome de tous les cancers
- ☐ **E.** Accompagnement de l'observance

CHAPITRE · Cancers et dépistage

Question 50 · intermédiaire · 2 bonnes réponses

Concernant l'incidence des cancers sur une période, quelles propositions sont exactes ?

- ☐ **A.** Elle désigne uniquement la survie à cinq ans
- ☐ **B.** La croissance et le vieillissement de la population peuvent augmenter le nombre absolu de cas
- ☐ **C.** Le dépistage et la qualité de l'enregistrement ne changent jamais le nombre de cancers diagnostiqués
- ☐ **D.** Elle décrit les nouveaux diagnostics sur une période
- ☐ **E.** Elle est identique à la létalité

Question 51 · difficile · 2 bonnes réponses

La survie nette standardisée d'un cancer :

- ☐ **A.** Est nécessairement la survie à un an
- ☐ **B.** Est utilisée pour comparer des pronostics
- ☐ **C.** Doit préciser l'horizon de suivi
- ☐ **D.** La survie nette standardisée est indépendante de toute méthode d'ajustement liée à l'âge
- ☐ **E.** Se confond toujours avec la mortalité brute

Question 52 · facile · 3 bonnes réponses

Les programmes organisés de dépistage des cancers en France comprennent :

- ☐ **A.** Tous les cancers sans distinction
- ☐ **B.** Col de l'utérus
- ☐ **C.** Colorectal
- ☐ **D.** Sein
- ☐ **E.** Pancréas pour toute la population

Question 53 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Le dépistage individuel est généralement :

- ☐ **A.** Évaluable en fonction d'antécédents familiaux
- ☐ **B.** Obligatoirement identique pour tous les âges
- ☐ **C.** Adapté au risque propre à une personne
- ☐ **D.** Différent d'une invitation standard de dépistage organisé
- ☐ **E.** Toujours une garantie de guérison

CHAPITRE · Synthèse transversale

Question 54 · difficile · 3 bonnes réponses

Une question compare « 639 000 naissances en France » à « 677 800 » en 2023. La bonne démarche :

- ☐ **A.** Conclure à une fraude statistique
- ☐ **B.** Vérifier le champ métropole / France entière
- ☐ **C.** Vérifier l'année
- ☐ **D.** Qualifier les sources
- ☐ **E.** Choisir au hasard la valeur la plus haute

Question 55 · facile · 1 bonne réponse

Pour interpréter un indicateur de santé publique, quel principe général faut-il privilégier ?

- ☐ **A.** Apprendre chaque nombre annuel par cœur avant tout
- ☐ **B.** Mémoriser des chiffres sans connaître les unités ni les dénominateurs
- ☐ **C.** Comprendre les tendances
- ☐ **D.** Confondre projection et observation
- ☐ **E.** Interpréter toute corrélation comme une causalité prouvée

Question 56 · intermédiaire · 3 bonnes réponses

Un même territoire connaît une charge importante de tuberculose et de diabète. Quelles conclusions sont exactes ?

- ☐ **A.** Le recul de certaines infections ne fait pas disparaître toutes les maladies infectieuses
- ☐ **B.** Les déterminants sociaux peuvent jouer sur ces deux groupes de maladies
- ☐ **C.** La présence du diabète rend la tuberculose non contagieuse
- ☐ **D.** Il peut cumuler maladies transmissibles et non transmissibles
- ☐ **E.** Ce cumul prouve qu'aucune transition épidémiologique n'existe

Corrigés argumentés

Retrouve ci-dessous les bonnes réponses et les explications pour comprendre chaque question.

CHAPITRE · Santé mondiale, OMS et One Health

Q01 · 2 réponses : B, D — La santé est multidimensionnelle et dépend de déterminants sociaux et environnementaux ; elle ne se limite pas à la maladie individuelle.

Q02 · 3 réponses : B, C, D — L'OMS oriente, coordonne et produit des références ; les systèmes nationaux assurent les soins et la mise en œuvre.

Q03 · 3 réponses : A, C, E — One Health relie les trois domaines humain, animal et environnemental, notamment pour les zoonoses et les résistances.

Q04 · 1 réponse : C — Une zoonose implique conjointement animal, environnement et être humain ; les autres choix ignorent ces liens.

CHAPITRE · OMD, ODD et pauvreté

Q05 · 3 réponses : A, B, D — Les OMD comprennent huit objectifs jusqu'en 2015 ; les ODD sont au nombre de 17 jusqu'en 2030 et l'ODD 3 porte sur la santé.

Q06 · 2 réponses : A, E — Pour comparer la pauvreté, il faut au minimum connaître le seuil monétaire, l'année et le champ étudié. La comparaison entre effectif et pourcentage nécessite aussi de vérifier le dénominateur ; l'énoncé qui prétend l'inverse est faux.

Q07 · 2 réponses : D, E — Une cible ODD est un objectif à atteindre que l'on peut suivre avec des indicateurs. Elle ne prouve pas que l'objectif est atteint, ne constitue pas une projection certaine et n'établit pas à elle seule la causalité.

Q08 · 3 réponses : C, D, E — Une baisse proportionnelle ne renseigne pas directement l'effectif sans taille de population ; il faut aussi fixer le seuil.

CHAPITRE · Indicateurs de santé

Q09 · 3 réponses : A, B, C — Les indicateurs décrivent, comparent et permettent un suivi. Un indicateur isolé n'établit pas nécessairement une causalité.

Q10 · 3 réponses : B, C, D — Des dénominateurs, durées et pyramides des âges différentes peuvent rendre les taux bruts trompeurs.

Q11 · 3 réponses : A, C, E — Prévalence, incidence et mortalité par cause sont des indicateurs de fréquence, apparition ou gravité.

Q12 · 3 réponses : A, D, E — Une estimation est fondée sur des données et hypothèses ; elle n'équivaut pas à une mesure exhaustive garantie.

CHAPITRE · Démographie et naissances

Q13 · 3 réponses : B, C, E — Le taux exprime une vitesse relative ; un taux positif mais décroissant accompagne toujours une hausse de l'effectif.

Q14 · 3 réponses : A, D, E — La variation totale est la somme du solde naturel (naissances moins décès) et du solde migratoire.

Q15 · 1 réponse : C — L'Insee donne 639 533 naissances en métropole et 677 803 en France entière pour 2023.

Q16 · 2 réponses : A, B — Une base étroite et des générations adultes plus larges sont compatibles avec un vieillissement et une moindre part de jeunes. La seule forme d'une pyramide ne démontre pas les causes exactes : il faut d'autres données.

CHAPITRE · Natalité, mortalité et espérance de vie

Q17 · 3 réponses : A, B, E — Il s'agit du nombre annuel de naissances vivantes rapporté à la population moyenne, exprimé pour 1 000 habitants.

Q18 · 2 réponses : D, E — Un taux brut dépend de la structure d'âge. Une population plus âgée peut présenter un taux brut supérieur sans que la qualité des soins soit nécessairement moindre. Les comparaisons nécessitent des ajustements appropriés.

Q19 · 3 réponses : A, D, E — L'espérance de vie de période applique les conditions de mortalité observées à une cohorte fictive ; elle ne prédit pas l'avenir individuel.

Q20 · 2 réponses : C, D — L'Insee indiquait 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes en 2023.

CHAPITRE · Mortalité maternelle

Q21 · 3 réponses : B, D, E — Un décès maternel survient pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant sa fin, pour une cause liée ou aggravée par la grossesse ou sa prise en charge, hors causes accidentelles ou fortuites. Ce n'est pas la définition de la mortalité néonatale.

Q22 · 2 réponses : D, E — Le RMM rapporte les décès maternels aux naissances vivantes, multiplié par 100 000.

Q23 · 1 réponse : E — L'objectif international de 2030 est un RMM mondial inférieur à 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Q24 · 2 réponses : A, D — L'OMS estime environ 260 000 décès maternels en 2023, soit près d'un décès toutes les deux minutes. Le rapport mondial de 197 décès pour 100 000 naissances vivantes est une estimation statistique, pas un recensement nominatif exhaustif.

CHAPITRE · Mortalité infantile et néonatale

Q25 · 2 réponses : A, B — La période néonatale correspond aux 28 premiers jours de vie (jours 0 à 27 révolus).

Q26 · 2 réponses : A, B — L'anglais distingue infant mortality (< 1 an) et under-five mortality (< 5 ans).

Q27 · 2 réponses : A, C — Les pays visent 12 décès néonatals et 25 décès avant cinq ans, respectivement pour 1 000 naissances vivantes.

Q28 · 3 réponses : A, C, D — Les deux mortalités diminuent dans l'ensemble, mais les disparités régionales restent fortes et les progrès récents ralentissent.

CHAPITRE · Incidence, prévalence et personnes-temps

Q29 · 3 réponses : A, B, D — Huit personnes déjà malades sur 100 à un instant représentent une prévalence de 8 %. On ignore combien de cas sont nouveaux ; il serait incorrect de parler d'incidence cumulée ou de cas par personne-année.

Q30 · 3 réponses : B, C, E — Neuf nouveaux cas parmi 100 personnes initialement indemnes suivies intégralement deux ans donnent une incidence cumulée de 9 % sur deux ans. Cela ne suffit pas à calculer une prévalence ni une densité d'incidence.

Q31 · 2 réponses : C, D — Le taux d'incidence rapporte les nouveaux cas à la somme des temps-personnes réellement passés à risque (personnes-années ou personnes-mois). Une durée non observée ne s'ajoute pas au dénominateur.

Q32 · 2 réponses : C, D — La densité d'incidence utilise le temps d'observation ; elle n'est pas une mesure directe de contagiosité.

CHAPITRE · Transition épidémiologique

Q33 · 1 réponse : C — Le cours montre une majorité des décès attribuables aux maladies non transmissibles au niveau mondial.

Q34 · 3 réponses : B, D, E — Les MNT comprennent notamment cardiovasculaires, diabète, cancers et maladies respiratoires chroniques. Paludisme et tuberculose sont infectieux.

Q35 · 1 réponse : C — La transition épidémiologique se manifeste souvent par la diminution relative du poids de certaines infections. Elle s'accompagne généralement d'un poids important des maladies chroniques et d'une amélioration de la survie ; elle n'efface pas toutes les infections.

Q36 · 3 réponses : A, B, D — Les disparités sanitaires dépendent des déterminants et de l'accès, et existent aussi à l'intérieur des pays.

CHAPITRE · VIH et sida

Q37 · 2 réponses : C, D — Le VIH est le virus ; le sida désigne la forme avancée avec immunodéficience sévère et complications.

Q38 · 2 réponses : B, D — Les antirétroviraux restent indiqués au stade sida et contribuent au contrôle de l'infection VIH. Il ne faut pas arrêter systématiquement le traitement ; les infections opportunistes éventuelles exigent une prise en charge adaptée.

Q39 · 3 réponses : B, C, E — La PrEP est proposée avant une exposition éventuelle au VIH ; le traitement post-exposition intervient rapidement après une exposition. L'éligibilité dépend du risque et des indications, pas du sexe : les femmes peuvent bénéficier de PrEP.

Q40 · 3 réponses : B, C, D — Une charge virale VIH durablement indétectable sous traitement supprime le risque de transmission sexuelle du VIH (I = I), sans protéger contre les autres IST ni supprimer le suivi médical.

CHAPITRE · Maladies transmissibles

Q41 · 3 réponses : A, B, D — Le paludisme est une maladie parasitaire transmise essentiellement par anophèle femelle ; P. falciparum peut être grave.

Q42 · 3 réponses : B, C, D — Les mesures antivectorielles et l'information sont des leviers majeurs ; elles ne remplacent pas le soin rapide des malades.

Q43 · 2 réponses : B, D — Une infection tuberculeuse latente peut rester silencieuse et n'est pas contagieuse par elle-même. Elle peut toutefois évoluer vers une tuberculose active ; la transmission aérienne concerne certaines maladies actives, notamment pulmonaires.

Q44 · 3 réponses : A, B, E — La tuberculose pulmonaire active se transmet par l'air ; le traitement est prolongé et la prévention respiratoire est déterminante.

Q45 · 1 réponse : D — Le cours cite Ebola parmi les risques infectieux émergents ou réémergents. Arthrose et dyslipidémie ne sont pas des maladies infectieuses. Une maladie émergente ne signifie pas automatiquement pandémie.

CHAPITRE · Maladies cardiovasculaires et prévention

Q46 · 3 réponses : B, D, E — HTA, dyslipidémie et tabagisme sont des facteurs majeurs ; le diabète s'ajoute souvent au risque.

Q47 · 1 réponse : A — L'AVC est une atteinte cardiovasculaire. Le VIH et le paludisme sont infectieux ; l'onchocercose est parasitaire. Les maladies cardiovasculaires comprennent également l'infarctus et l'insuffisance cardiaque.

Q48 · 3 réponses : B, C, E — Un effectif dépend de la population exposée ; le taux standardisé vise à neutraliser l'effet des différences de structure d'âge.

Q49 · 3 réponses : B, C, E — Le soin infirmier associe surveillance, prévention, information et collaboration, sans remplacer les compétences médicales.

CHAPITRE · Cancers et dépistage

Q50 · 2 réponses : B, D — L'incidence concerne les nouveaux diagnostics pendant une période. La croissance démographique et le vieillissement peuvent augmenter leur nombre absolu ; le dépistage et la qualité des registres influencent aussi les cas observés. Ce n'est ni la létalité ni la survie à cinq ans.

Q51 · 2 réponses : B, C — La survie nette aide à estimer le pronostic en s'affranchissant des décès attendus d'autres causes ; la standardisation permet de comparer en tenant compte des structures d'âge. Il faut préciser l'horizon, par exemple cinq ans.

Q52 · 3 réponses : B, C, D — Les programmes de dépistage organisé en France concernent le sein, le côlon-rectum et le col de l'utérus selon des conditions d'âge ou de risque. Il n'existe pas de dépistage organisé universel de tous les cancers.

Q53 · 3 réponses : A, C, D — Le dépistage individuel suit une évaluation personnalisée ; il ne doit pas être confondu avec un programme systématique.

CHAPITRE · Synthèse transversale

Q54 · 3 réponses : B, C, D — Les chiffres décrivent des périmètres distincts ; l'année et la source doivent accompagner la valeur.

Q55 · 1 réponse : C — Le support demande de lire les tendances et leurs indicateurs en précisant population, période, territoire et unité ; une valeur isolée n'explique pas une évolution.

Q56 · 3 réponses : A, B, D — La double charge désigne la coexistence d'infections et de maladies non transmissibles. Le vieillissement et les progrès contre certaines infections n'en éliminent pas toutes les formes ; la situation sociale peut influencer les deux catégories.